



到達目標

- 漢方薬と西洋薬の治療目標が異なることを理解できる
- 病名治療のほうが処方しやすいが、病態に合わせた治療の重要性を理解できる
- 患者から適切な処方を学ぶという考えが重要であることを理解できる
- 漢方薬に含まれる構成生薬の薬能を考えて処方することも重要であることが理解できる

1 漢方医学

a 漢方医学の西洋医学における立ち位置

「漢方医学と西洋医学の相違を理解すること」、「漢方薬の薬理作用と副作用を理解すること」が基本である。漢方治療は西洋医学を基盤として施行すべきであり、東西医学の融合には臨床の現場における実践が何よりも必要である。実際の医療において患者から適切な処方を学ぶことも多いという認識が必要である。

b 漢方医学の考え方

漢方医学の考え方の特徴は、①全人的医療（心身一如の治療）、②全身の調和を図る医療（過剰は取り去り、不足は補う）、③オーダーメイド医療（随証療法）である。西洋医学による治療で届かない部分を補う。漢方の考え方は、「身体がだるい」を「気の不足」と考えて、「気を補う治療」で対処する。

2 咳嗽に対する漢方治療

西洋医学の鎮咳薬は中枢性鎮咳薬であり、延髄の咳嗽中枢活動を抑制することにより咳嗽の改善を図っている。しかし臨床的効果に乏しいため、中枢性鎮咳薬の

使用は推奨されていない。疾患特異的な治療薬は末梢性に作用する薬剤であり、原因に応じた特異的治療を行うことが重要であると「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン」の中で強調されている。漢方医学では病態に応じて咳嗽緩和治療を行う。代表的治療薬に関して概説する。

a 麦門冬湯

麦門冬湯は「喉を潤し咳を鎮める効果があり、痰の少ない乾性咳嗽に用いる。主薬は麦門冬である」と漢方古典に記載されている。半夏・大棗は自律神経の鎮静作用、甘草は抗炎症作用を有しており、麦門冬の鎮咳去痰作用と合わせて鎮咳薬として作用する（図1）。麦門冬湯は気道炎症時に起こる気道上皮細胞の誘導型 NO 合成酵素（iNOS）の産生を抑制、その結果 C 線維末端のアナンドアミドトランスポーター活動が抑制され、神経ペプチドの遊離が抑制される。神経ペプチドは気道 A δ 線維を刺激して咳嗽が発生する（神経原性炎症）が、麦門冬湯はこの経路を抑制する。さらに麦門冬湯は気道上皮細胞の Aquaporin-5 を活性化して粘液分泌を亢進、喉を潤すことにより咳を鎮める作用を有している。喉のイガイガ感で咳が出る、喉に喀痰が絡まるという場合に、末梢性鎮咳薬として作用する。

b 麻黄湯

インフルエンザウイルス感染時は高率に咳嗽が発生する。発熱、咳嗽、腰痛、節々が痛いという自覚症状を有している場合、インフルエンザウイルス感染の確率が極めて高い。この場合の咳嗽には、抗インフルエンザ吸入薬と併用して、鎮咳薬よりも麻黄湯の方がより早期の効果が期待できる。麻黄の主成分はエフェド

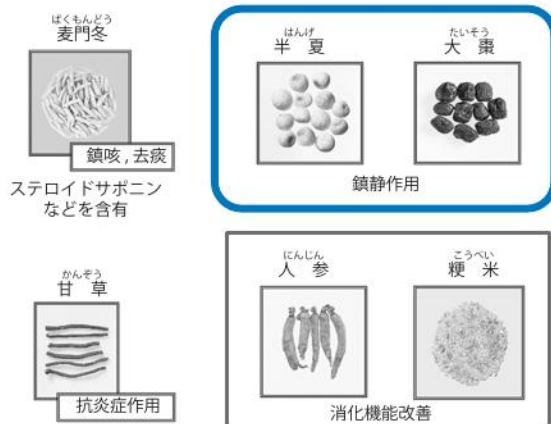


図1 麦門冬湯の構成生薬と薬理作用機序